

LA CONSULTA PEDIÁTRICA

Dr. Saúl Gleich

*Agradezco su colaboración y aportes al Dr. Carlos Luzzani
y al GRUPO PEDAMB de la Sociedad Argentina de Pediatría.*

“Atender al paciente de la misma manera como quisiera ser atendido”

¿POR QUÉ LA CONSULTA?

El objetivo de este trabajo sobre la consulta pediátrica integral es compartir y reflexionar con mis colegas sobre un instante fundamental del ejercicio de nuestra especialidad médica.

La consulta es la base fundamental del ejercicio de la medicina y sobre la cual se construye el vínculo médico/paciente/familia.

La consulta es el acto médico por excelencia, el punto de contacto entre dos personas. Es la esencia misma de la medicina, está cargada de sentido, tensiones y expectativas trascendentes.

Cada consulta es “única”, por el cambio de los personajes, los mensajes y los modos.

La comunicación es la base de la consulta, “sin comunicación no hay consulta”. El profesional debe adaptarse al paciente, no al revés.

En el caso de la entrevista pediátrica, se agregan como interlocutores los cuidadores, padres, abuelos, etc., en el caso de ser niños pequeños.

No existe especialidad médica que tenga tantas y tan variadas composiciones de los demandantes de la consulta. Existen consultas prenatales, del recién nacido, del lactante, del niño preescolar con lenguaje, del escolar, del adolescente, del acompañado por los dos padres, por uno solo, por el encargado de su cuidado, etc.

El paciente aporta sus dudas y temores sobre su salud o enfermedad, y el médico su conocimiento y experiencia personal.

Partimos de la base de que, si el paciente no entendió las indicaciones y diagnóstico de su dolencia, es “siempre” culpa del médico.

¿Por qué se habla poco de ella en los textos de enseñanza?

¿Por qué no está incluida en los currículos de las residencias?

¡Porque de esto no se habla demasiado!

CONSULTA / LA ENTREVISTA / POSCONSULTA

¿Cuándo comienza una consulta y cuándo termina?

¿Quién decide el fin de la entrevista y de la consulta? ¡¡¡EL PACIENTE!!!!

Diferencias entre consulta, entrevista y posconsulta:

La consulta comienza cuando el paciente y su familia deciden concurrir a una entrevista con el pediatra y finaliza cuando se solucionó el motivo de la atención.

La entrevista es la interacción entre los dos espacios: paciente / profesional, que se genera durante el intercambio personal de la consulta, es decir, es una parte de la consulta.

La posconsulta es una alternativa válida que debe tener todo paciente ante una eventual mala evolución de la enfermedad en tratamiento o resolución de alguna duda que haya quedado sin contestar.

ÁMBITOS DE LA CONSULTA

Consultorio: privado, obra social, institucional hospitalario o sanatorial.

Domicilio: pacientes propios o prestaciones a través de sistemas de atención domiciliaria.

Telefónica: fijos o celulares.

On-line: mensajes de texto o WhatsApp.

Informal: en pasillos, reuniones familiares, sociales, etc.

PASOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE UNA CONSULTA AMPLIADA INTEGRAL

1.- La elección del pediatra

¿Cómo se elige un pediatra?

- Por prestigio.
- Por accesibilidad geográfica.
- Por accesibilidad económica.
- Por ser el único de la región.

Hay alternativas que hacen que la elección sea por obligación, en cuyo caso podría ser válida la elección de un médico clínico comunitario.

¿Qué pediatra elijo para mi hijo?

Cualidades que le pido a mi pediatra:

- Cálido.
- Con calidad.
- Amable.
- Actualizado.
- Escuchador.
- Examinador.
- Integral.
- Previsor.
- No medicalizador.
- Explicador.
- Posconsultor.
- Todo terreno.
- Contenedor.
- Compañero.

¡Solo con la capacidad y la actualización científica no alcanza! El prestigio profesional es la base de la elección, pero hay atributos que hay que agregarle para elegir correctamente al pediatra que atienda a nuestros hijos, nietos.

Cada familia elige el *target* de pediatra que más le guste, pero en mi caso, de tener que elegir un pediatra para mi nieto, le aconsejaría que sea, además de

capacitado y actualizado, cálido, contenedor, escuchador, amable, explicador, integral, posconsultor, no medicalizador, previsor, etc.

2.- La sala de espera

El desafío es saber convertir el tiempo muerto de la espera en algo educativo y productivo.

Tratar de dar respuestas a dudas de las familias redundará en economía del tiempo de la entrevista.

Sala de espera educadora. Con videos o lecturas adecuadas que alivian la espera de la atención.

Debe tener consignas de educación y promoción de la salud de fácil lectura y comprensión. Además debe ser amplia, cómoda, para que todos puedan esperar sentados, y bien ventilada y acondicionada la temperatura.

Rincones para juegos y lectura también son importantes en la sala de espera.

Sala de espera enfermante es aquella que está mal ventilada, acondicionada y con hacinamiento por un exceso de pacientes y familias que esperan.

La magnitud de la sala de espera debe ser calculada sabiendo la cantidad de pacientes que concurrirán.

Si esta demanda es muy alta, habría que implementar una estrategia para limitarla u ordenarla y de esa manera evitar las congestiones de pacientes.

Debe funcionar como un consultorio de admisión, al cual el pediatra debe salir cada tanto y ver el estado de los pacientes que esperan, para decidir si es necesario atender a alguno antes de su turno por presentar signos de alarma o de riesgo. Otra alternativa es capacitar a la recepcionista o enfermera que trabaja en la sala de espera en criterios de urgencia para la detección rápida del paciente que lo requiera.

Es fundamental que la recepción del paciente sea amable y acogedora, explicando, si hay demoras, los motivos de ella, para evitar malhumor familiar.

3.- Consultorio adecuado

Amplio para que el paciente pueda deambular; cálido para evitar enfriamientos al desnudarlo para su examen físico; luminoso, si es posible con luz natural y sin riesgo de accidentes; cómodo para la familia.

Además debe garantizar privacidad, sobre todo en las entrevistas de los adolescentes.

Es fundamental que el ambiente no contenga elementos que puedan asustar a los niños, como aparatos, delantales, máscaras o barbijos; en caso de que necesiten estar, su uso y sus aplicaciones indoloras deben ser explicados al niño.

Además es bueno, si es posible, dejar jugar al pacientito con algunos elementos antes del examen físico, para entrar en confianza y relajarlo.

En general los ambientes nuevos para el niño son amenazantes y generan actitudes defensivas que dificultan un buen examen.

4.- Turnos vs. orden de llegada

Este es un tema complejo y de distintas lecturas, todas válidas. Considero los turnos una alternativa que limita la tarea del médico en el sentido de la duración de la entrevista y que, en el caso de no cumplirse, genera mal humor en la familia.

La atención por orden de llegada también tiene sus problemas, ya que genera la concurrencia de los pacientes antes de la hora de consulta, para conseguir los primeros turnos y tiempos de espera difíciles de calcular.

Lo ideal, a mi entender, es hacer un *mix* dejando espacios libres entre los turnos para atender las demandas urgentes (según el criterio de la familia).

Si al paciente se le da el tiempo que necesita cada vez que lo atienden, no se molestará mucho por la espera, ya que entiende la dinámica de la entrevista y sabe que él también tendrá el suyo.

Los tiempos flexibles de las entrevistas son aceptados y entendidos por los pacientes, y eso es importante para que, al ingresar a la entrevista, no estén de mal humor.

5.- Saludo médico-paciente/familia

“El primer acto médico de tratamiento es dar la mano al enfermo” (Von Leyden, 1900).

Saludar como un amigo a otro, no como médico a paciente.

Base del saludo: apretón de manos o beso en la mejilla, mirada a los ojos y saludo tranquilo.

Recibir en la puerta, parado, llamándolo por su nombre de pila y recibéndolos con un firme apretón de manos, abrazo o beso, según familiaridad, y con un “mucho gusto, Dr.....” en la primera consulta.

Tomar al bebé en brazos y alabarlo por alguna característica que al pediatra le impacte en ese momento.

Tomar asiento para charlar.

La calidad humana del encuentro médico-paciente es decisoria para el éxito del resto de la entrevista.

6.- Escuchatorio

Laín Entralgo: “No puede haber una clínica fina si el que la practica no ha aprendido, mucho más sutilmente que hasta ahora, a OÍR”.

Antes del escuchatorio, es bueno hablar de un tema trivial, familiar, que sepamos que a la familia le gusta, como viajes, deportes, actualidad, etc.

En esta charla previa es importante dirigirse a todos los presentes, incluido el niño si tiene edad para ello.

La inclusión del niño en la charla lo relaja y lo predispone mejor para el examen físico.

Si se ve que el paciente o la familia no presentan ningún signo de alarma de enfermedad importante (dificultad respiratoria, obnubilación, sopor, cianosis, deshidratación, fiebre, etc.) la duración de la charla puede ser más extensa.

En los casos en que el niño no esté en buen estado general, se altera el ritmo de la entrevista acortando los saludos y los pasos previos al examen físico.

Son distintas las dinámicas de las consultas por patología aguda o crónica o por un control de salud.

Es bueno que la madre traiga escritas las dudas o preguntas que tenga, para así poder evacuar todas las dudas y no olvidarse de ninguna.

Es bueno que, si el chico deambula, gatea o camina, lo dejen suelto, así comenzamos el examen físico o inspección de modo informal.

7.-Tiempo para jugar con el paciente

Durante el escuchatorio o previamente al examen físico, es de buena técnica dirigirse a los chicos y jugar con algún objeto o juguete que le atraiga, para disminuir la tensión del paciente.

8.- Examen físico relatado

Una vez terminado el diálogo de comienzo, se pasa al examen físico formal.

Siempre completamente desnudo.

Dejar para el final las maniobras semiológicas invasivas y/o dolorosas, como usar el bajalengua, el otoscopio, o revisión de la zona genital.

Tratar de tener las manos a temperatura adecuada y de cubrir el estetoscopio con alguna prenda del niño, para evitar enfriamientos que generan llanto, rechazo o malestar del niño.

Comenzar siempre acariciándolo para darle seguridad y tranquilidad necesaria para poder realizar un examen físico minucioso.

Pesar al niño siempre en las mismas condiciones, desnudo y sin pañales. En los pacientes que no se sientan, es buena práctica acostarlos sosteniéndolos suavemente contra la camilla, para evitar movimientos bruscos y darle seguridad.

Para acortar los tiempos de la pesada, es conveniente poner la barra en el peso teórico que se piensa tiene el niño antes de acostarlo o sentarlo en la balanza.

No siempre seguir una misma secuencia de examen físico, ya que hay que adecuarse al pacientito, porque hay niños a los que no les gusta acostarse de entrada, sino luego de una entrada en confianza.

La zona genital debe ser siempre lo último que se revisa, y si el paciente es grande habría que pedirle autorización para su realización.

Es importante incluir a la madre en el examen físico para que ayude sosteniendo al niño y hablándole para tranquilizarlo en aquellas revisiones “difíciles”.

Los exámenes de pacientes que no se dejan revisar pueden ser solo parciales, dirigidos al motivo de la consulta, dejando el resto de la semiología para una próxima entrevista, en la que haya entrado en confianza y mejorada la relación niño-pediatra. Flexibilizar la rutina del examen ayuda a realizar una semiología más completa; es importante comenzar con un juego de manos suave para disminuir la resistencia del niño.

Dejar lo más molesto para el final y que sea rápido es de buena técnica.

Mantener la calma en la voz y en los gestos es importante para lograr un examen más exhaustivo.

Comentar los datos que uno está buscando en cada maniobra y su resultado en voz alta, para que los padres se queden tranquilos y sientan que la revisión es completa y meticulosa.

Los datos positivos se explicarán una vez terminado el examen físico y vestido el niño. Nunca explicar mientras se lo está vistiendo o cuando la madre está de espaldas.

Tratar de esperar a que el niño esté vestido, no llore y se encuentre tranquilo para pasar al siguiente paso.

Sonreír siempre al pacientito, sobre todo al lactante, luego de que adquiera la “sonrisa social”. Los chicos asocian ese gesto con “todo está bien”.

9.- La receta eficiente

Debe ser escrita mientras visten al niño, con letra clara y sin abreviaturas.

Evitar la “letra de médico”, como se conocen vulgarmente los contenidos ilegibles de las recetas.

Fundamental es tener un vademécum acotado de medicamentos, bien conocida la farmacología clínica de cada uno, para así evitar las reacciones adversas y usar las dosis adecuadas para cada paciente. Un vademécum

pediátrico ambulatorio no debería tener más de 10 drogas, que solucionen el 90% de las consultas.

Además se deben conocer las presentaciones y los gustos de los distintos medicamentos que se indiquen y así poder recetar un solo frasco para un tratamiento; se consigue con esto mayor cumplimiento y abaratar los costos. Aclarar además bien la duración del tratamiento total, relación de la ingesta de la droga con respecto a los alimentos y proporcionar horarios lógicos, evitando las dosis de la madrugada que se sufren y muchas veces no se cumplen. Para no tener problemas con las dosificaciones por cucharita o por mililitros, es útil indicarles la compra de una jeringa de 5 o 10 ml, para que la usen como medida universal de todas las presentaciones líquidas.

10.- Explicación diagnóstico y tratamiento

La explicación de los diagnósticos y de las indicaciones debe ser realizada en las mismas condiciones que el escuchatorio: sentados, con el niño calmado y sin prisa.

El vocabulario debe ser simple y fácilmente comprensible por la familia. Hacer hincapié en lo fundamental que es realizar el tratamiento completo para evitar complicaciones y/o recaídas.

Incorporar siempre en la entrevista conceptos de prevención de accidentes (de acuerdo con la edad del paciente), pautas nutricionales y de estilo de vida familiar saludables.

11.- Reafirmar la comprensión de la familia

Este es un paso fundamental en la entrevista, ya que debemos cerciorarnos de que la familia no tenga dudas sobre el diagnóstico de su hijo y de que haya entendido las indicaciones escritas que se lleva.

Es de buena práctica hacer leer la receta a la madre y preguntarle si tiene alguna duda, para cerciorarnos de que la indicación haya sido entendida.

En los casos en que la madre no entienda lo escrito, es bueno reemplazar esa receta por otra con un instructivo basado en dibujos para mejor comprensión.

12.- Aceptación de la familia

Este es el último paso de la entrevista. Fundamental es que sepamos que la familia no tiene dudas de la comprensión del diagnóstico y de las indicaciones, para que puedan ser cumplidas correctamente.

Otro elemento es averiguar la posibilidad de la adquisición del medicamento indicado.

13.- Posconsulta asegurada

Hablar sobre cómo seguir con los controles evolutivos de la enfermedad o de las interurrencias o reacciones adversas que se presenten:

- Teléfono celular.
- Correo electrónico.
- Guardia que prefiere que lo atienda si hay imposibilidad de hacerlo uno mismo.
- Visita domiciliaria.

14.- Fin de la entrevista

Esta es la pregunta que no debe faltar antes de finalizar:

¿QUEDA ALGUNA DUDA?

La familia es la que decide el fin de la entrevista. De esa manera nos asegura el cumplimiento de las indicaciones que surgieron de ella.

Lo importante es que la familia y el pediatra queden satisfechos y plenos al finalizar la entrevista.

La despedida debe ser igual de cordial y cálida que la recepción, con un “avísenme como sigue”.

Esta secuencia sufre algunas variaciones en el caso en que el ámbito sea distinto al consultorio médico.

La consulta pediátrica domiciliaria es para mí la *vedette* y la más completa de los tipos de consulta.

¿Por qué pienso así?

- Porque se trabaja en el lugar donde el paciente está más cómodo.
- Porque evita mucho tiempo del interrogatorio sobre el entorno en que se desarrolla la actividad diaria del niño.
- Porque descubre datos que fueron ocultados o no buscados en la consulta institucional.
- Porque da una noción real sobre los hábitos de limpieza, orden y cuidados de la familia.
- Porque conoceremos el barrio y la zona de influencia del domicilio del paciente.
- Porque evaluamos la cercanía o lejanía de la casa de los centros de salud y de los medios de comunicación.
- Porque es la sala de espera más cómoda y con menor capacidad de contagio que existe.
- Porque podemos evaluar las posibilidades de cumplimiento de las indicaciones que le entregamos a la familia.
- Porque las familias valoran enormemente la visita del médico en su domicilio.
- Porque fundamentalmente conocemos el medioambiente socioeconómico real de la familia de nuestro paciente.

REFLEXIONES

“LA PRISA ES EL PEOR ENEMIGO DE LA BUENA MEDICINA”.

¿Cuánto debe durar una entrevista pediátrica?

Saludo	1 min
Escucha informal	3 min
Escucha formal	5 min
Desvestir al niño	3 min
Jugar con el niño	2 min
Examen físico	10 min
Vestir al niño y escritura de indicaciones	3 min
Explicación diagnóstico y receta	5 min
Aceptación por parte de la familia	3 min
Saludo final	1 min
Total aproximado	+/- 30 minutos.

¿CUÁNTO DEBE VALER UNA CONSULTA PEDIÁTRICA AMPLIADA?

Consulta ampliada: bio-psico-socioeconómica-ambiental-temporal.

Duración mínima promedio: 30 minutos.

¡ASIGNATURA PENDIENTE!

Preguntas con varias respuestas:

¿Qué sistema de salud contempla 30 minutos de duración de la consulta pediátrica?

¿Qué sistema de salud elimina la carga administrativa y burocrática de la consulta?

¿Cuándo se recuperará el diálogo con el paciente/familia en lugar de con el financiador?

CONCLUSIÓN

Que se cumpla lo dicho por Sydenham:

“NADIE HA SIDO TRATADO POR MÍ DE MANERA DISTINTA A LA QUE YO QUISIERA SER TRATADO”.

DERECHOS DEL NIÑO:

Responder a sus demandas:

Ser esperado con entusiasmo por la familia.

Ser nombrado seguido.

Que lo amamenten.

Que lo alimenten.

Que lo amen.

Que lo miren.

Que busquen su mirada. Contacto visual.

Que lo cuiden.

Tener contacto físico de piel a piel.

Que lo quieran mantener seguro, contenido, contento.

Que sepan ver el discomfort, no todo es hambre.

Que lo ayuden a relajarse.

Que le tengan paciencia.

Que duerman cerca, pero no colecho.

Que mis papis:

me miren,

me toquen,

me hablen,

me lean,

me sostengan.

Que jueguen conmigo.

Que me enseñen a jugar.

Que me enseñen a mirar el entorno.

Que me cambien de posición.

Que interpreten mis llantos.

Que me den seguridad.

Que me den rutinas diarias.

Que no sean impacientes.

Que me tengan paciencia.

Que respeten mis tiempos.

Que me acunen.

Que me canten.

Que me acaricien.

Que me acompañen.
Que me reconforten.
Que no fumen.
Que no griten.
Que no se peleen.
QUE ME ELIJAN UN BUEN PEDIATRA DE CABECERA.
Que cure a veces.
Que alivie a menudo.
Que acompañe siempre.
Que sea feliz con el ejercicio de su profesión.
Que sea capacitado.
Que se comunique fácil con mis padres.
Que me conozca por mi nombre.
Que me revise suavemente.
Que me revise completo (desnudo).
Que no me maltrate (que no me pinche).
Que no me sobre ni sub medique.
Que calme y eduque a mi entorno.
Que me escuche a mí y a mis padres.
Que escriba claro y legible.
Que explique bien.
Que nos dé el tiempo de entrevista que necesitemos.
Que nos dé buenos consejos.
Que sea mi amigo.
Que me acaricie, me quiera y me abrace.
Que me tenga paciencia.
Que no me despache.
Que me haga una semiología ampliada y completa.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Boggiano, Emilio. Manual para la supervisión de la salud 2011 SAP. Pág. 49.
- 2.- Kremenhusky José R., El desarrollo del cachorro humano, Pág. 37, Editorial Noveduc.
- 3.- Meneghelo, Julio; Grau Martínez, Arturo. Pediatría Práctica en diálogos.
4. Rodríguez Arce, María Antonieta. La relación médico paciente. Pág. 39, Editorial Ciencias Médicas – Cuba.
- 5.- Plata Rueda. La consulta en Pediatría.